

Orçamento

INDICADO POR:

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

DANIEL GENRO MOREIRA

IDADE: 58 PESO: 85 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Aposentado / Turnos incluídos
SINTOMAS: mto Anos.

QUEIXAS: Dorco, Cansaco, Acorda comido, SED, A memória / Foco.

MEDICAMENTOS: Vitaminas

MÉDICO: Dr. Carla dasimas otomno.

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: ☒

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h 23h30' HORA QUE ACORDA: 07h

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N Cachaca / Chaudito

FUMO: (X) S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: parou há 15 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: 4 IAH: 28,2 SPO2: 88%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA Em investigação extra-sistémica.

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: 91% PRESSÃO NO EXAME: 5,0 cmH2O

↳ IAH 2,5 e 1h

23/07 foi usado aparelho intra-oral mas alterou ATM
2005 ↳ tem PSG de 2023 com IAH.

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: DANIEL GENRO MOREIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 20-05-2025

Idade: 58 anos

Peso: 85 kg

Altura: 1,80 m

Médico Solicitante: DR. CARLOS HENRIQUE LABINAS
DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 20/05/2025 21:50 e finalizado às 21/05/2025 05:46.

A latência para início do sono foi de 18,5 min e a latência para o sono REM de 60,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 447,0 min, com eficiência do sono de 93,9 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 4,0 % de estágio N1, 67,4 % de estágio N2, 7,2 % de estágio N3 e 21,4 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 10,4 min. Ocorreram 241 despertares, sendo o índice de 30,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 210, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 210 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 28,2 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 19,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 30,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 28,2 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 28,2 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 93% e a mínima de 88%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 24,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 15,7 (nº/h) e em NREM foi de 29,2 (nº/h). Permaneceu 0,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (28,2 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (88%);
3. Latência para o início do sono (18,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (60,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (93,9 %) (VN= $\geq$ 85%);
6. Índice de despertares 30,4 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (4,0 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (67,4 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (7,2 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (21,4 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

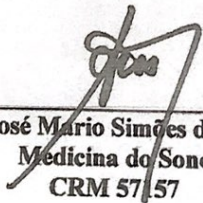
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderada.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57